

# **MODUL PEMBELAJARAN**

## **BLOK**

# **SPECIAL SENSE**



### **PENYUSUN**

**dr. Alvi Milliana, M. Biomed**

**dr. Yuliono Trika Nur Hasan, Sp.M**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2025**

**MODUL PEMBELAJARAN BLOK**  
**SPECIAL SENSE**  
**(KODE MK. 20070111C18)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2025**

# **TIM PENYUSUN**

**MODUL PEMBELAJARAN BLOK SPECIAL SENSE**

**SEMESTER GENAP**

**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**dr. Alvi Milliana, M. Biomed**

**dr. Yuliono Trika Nur Hasan, Sp.M**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Alhamdulillahirobbil alamin

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Pembelajaran Blok *special sense* mengikuti perkembangan terbaru kurikulum pendidikan dokter nasional.

Buku Modul Pembelajaran Blok *special sense* berisikan rincian tahapan proses pembelajaran yang akan ditempuh mahasiswa dalam mengikuti Blok *special sense* meliputi metode kegiatan belajar, metode penilaian, jadwal pembelajaran dan sumber referensi. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dalam menyusun rencana belajarnya sehingga luaran pembelajaran yang disusun oleh unit pendidikan kedokteran dapat mencapai profil lulusan sesuai visi misi Program Studi dan Fakultas.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Saran dan kritik senantiasa akan kami tampung untuk penyempurnaan pada modul-modul berikutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Malang, 19 Maret 2025

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....3

DAFTAR ISI .....4

I. PENDAHULUAN .....5

II. TUJUAN PEMBELAJARAN.....1

III. METODE KEGIATAN BELAJAR .....6

IV. POHON TOPIK .....7

V. PENILAIAN .....19

VI. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....19

VII. REKAP PEMBELAJARAN .....49

VIII. REFERENSI .....73

IX. JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER 6 ..... **Error!**  
**Bookmark not defined.**

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Deskripsi Blok

Blok *special sense* merupakan blok ke-18 yang memiliki bobot sebesar 5 sks. Blok *special sense* akan dijalankan selama 5 minggu dengan perincian 4 minggu fase pembelajaran aktif serta 1 minggu fase ujian. Dalam blok ini, Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip ilmu klinik penyakit di bidang oftalmologi, telinga hidung dan tenggorok-kepala leher secara integratif, holistik dan komprehensif sebagai dasar dalam mengelola masalah kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

## 1.2 Bahan kajian

Dalam proses pembelajaran Blok *special sense* penting untuk kita merecall dan memahami kembali materi-materi ilmu kedokteran dasar dalam blok:

- Biomedik 1 utamanya pada topik biologi sel, epitel, jaringan ikat, genetika, dasar imunologi, somatosensoris, saraf otonom
- Mekanisme Dasar Penyakit pada topik mikrobiologi agen penyebab infeksi, inflamasi, patogenesis keganasan.

Penguasaan materi Blok *special sense* menjadi dasar dalam pembelajaran dalam Blok:

- Traumatologi dan Kegawatdaruratan
- Pediatri
- Geriatri
- Kedokteran Komunitas
- Kedokteran Haji

Penguasaan ilmu klinis penyakit oftalmologi, telinga hidung dan tenggorok-kepala leher dalam blok ini menggunakan prinsip integrasi vertikal dimana materi anatomi-histologi, fisiologi, biokimia-biomol, patologi anatomi, patologi klinik akan dipelajari secara komprehensif dengan ilmu-ilmu klinis.

Selain itu, Blok *special sense* merupakan integrasi pembelajaran bidang Ilmu Oftalmologi, THT-KL, Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Bedah.

### 1.3 Tim dosen

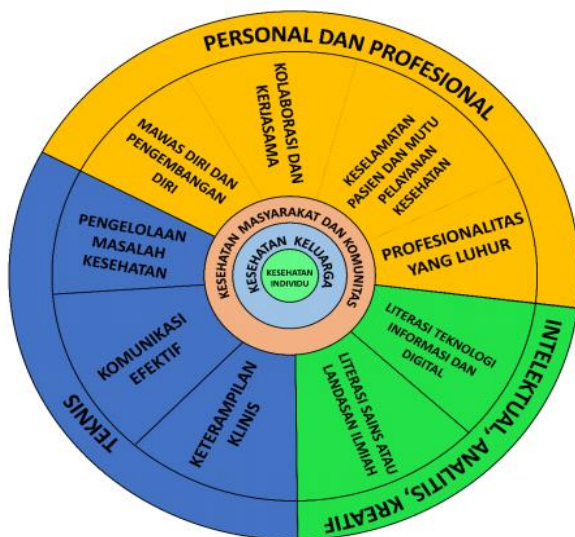
Pembelajaran dalam Blok Kardiovaskuler melibatkan tim dosen yang terdiri dari beberapa departemen diantaranya:

1. Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes, Sp.Rad (K) – Departemen Radiologi
2. dr. Alvi Milliana, M. Biomed – Departemen Ilmu Biomedik (Mikrobiologi) [Koordinator Blok]
3. dr. Yuliono Trika Nur Hasan, Sp. M – Departemen Ilmu Kesehatan Mata (Kontributor Blok)
4. dr. Faridatul Jannah, Sp. THT-KL — Departemen Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorok
5. dr. Berlian Anggraeni Putri, SpPA – Departemen Ilmu Patologi Anatomi
6. dr. Nurlaili Susanti, M. Biomed – Departemen Ilmu Biomedik (Farmakologi)
7. dr. Doby Indrawan, MMRS – Departemen Ilmu Bioetik

## II. TUJUAN PEMBELAJARAN

### 2.1 Area Kompetensi dan Capaian Pembelajaran

Blok special sense adalah mata kuliah yang disusun dalam mewujudkan capaian pembelajaran yang menggambarkan berbagai kemampuan peserta didik di akhir suatu program pendidikan dan merefleksikan pengetahuan, keterampilan, nilai secara utuh, dan terintegrasi serta merupakan gabungan dari berbagai area Kompetensi yang relevan. Sembilan area kompetensi SNPPDI 2019, dikelompokkan lagi dalam 3 aspek, seperti ditunjukkan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kelompok Area Kompetensi

Lingkaran terluar merupakan 3 kelompok area kompetensi yang terdiri atas: (AK1) personal dan professional, (AK2) teknis, (AK3) intelektual, analitis, kreatif. Lingkaran kedua adalah area kompetensi yang masuk pada tiap kelompok. Kelompok area kompetensi personal dan professional mencakup beberapa area kompetensi yang lebih spesifik yaitu (AK1.1) profesionalitas yang luhur, (AK1.4) keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan, (AK1.3) kolaborasi dan kerjasama, (AK1.2) mawas



diri dan pengembangan diri. Kelompok area kompetensi intelektual analitis dan kreatif terdiri atas: serta (AK2.1) literasi sains atau landasan ilmiah serta (AK2.2) literasi teknologi informasi dan digital. Kelompok area kompetensi teknis mencakup area kompetensi (AK3.1) pengelolaan masalah kesehatan dan sumber daya, (AK3.2) komunikasi efektif, dan (AK3.3) keterampilan klinis.

Berikut adalah penjabaran area kompetensi, beserta capaian pembeda-lajaran yang menjadi rujukan dalam perumusan tujuan pembelajaran Blok *special sense*.

### Kelompok Area Kompetensi 1

|               |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AK1.1.</b> | <b>Profesionalitas yang luhur</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>A1.1</b>   | Berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral dan etika akademik sesuai perannya sebagai mahasiswa kedokteran.                                                                                         |
| <b>A1.2</b>   | Memiliki kesadaran untuk bersikap dan berupaya maksimal dalam praktik kedokteran                                                                                                                                   |
| <b>A1.3</b>   | Merumuskan alternatif keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada praktik kedokteran                                                                                                                          |
| <b>AK1.2</b>  | <b>Mawas diri dan pengembangan diri</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>A2.2</b>   | Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri dan profesionalisme.                                                                                                            |
| <b>A2.3</b>   | Melakukan refleksi diri, mawas diri dan evaluasi diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, identifikasi kebutuhan belajar secara terus menerus dikaitkan dengan peran sebagai mahasiswa kedokteran. |
| <b>A2.4</b>   | Mengatasi tantangan dan tekanan tugas sebagai mahasiswa kedokteran dan menunjukkan ketangguhan dalam mengatasi tantangan dan tekanan                                                                               |
| <b>A2.5</b>   | Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya, pengetahuan dan keterampilan diri sendiri dalam mengembangkan profesionalisme.                                                      |
| <b>A2.6</b>   | Menerapkan kemampuan berpikir kritis, menghasilkan ide yang relevan dan berinovasi untuk menyelesaikan masalah.                                                                                                    |
| <b>AK1.3</b>  | <b>Kolaborasi Dan kerjasama</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>A3.1</b>   | Menerapkan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip, nilai dan etika yang berlaku                                                                                                                            |

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A3.2</b>  | Menerapkan Kepemimpinan dalam pembelajaran kolaboratif.                                            |
| <b>A3.3</b>  | Menerapkan komunikasi efektif antar mahasiswa kedokteran, profesi kesehatan lain dan profesi lain. |
| <b>A3.4</b>  | Melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kolaboratif                                               |
| <b>AK1.4</b> | <b>Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan</b>                                                       |
| <b>A4.1</b>  | Menguasai prinsip keselamatan pasien dalam pengelolaan masalah kesehatan.                          |
| <b>A4.4</b>  | Mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang mempengaruhi keselamatan pasien.                      |
| <b>A4.5</b>  | Mengidentifikasi faktor lingkungan dan manusia untuk meningkatkan keselamatan pasien               |

## Kelompok area Kompetensi 2

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AK2.1</b> | <b>Literasi Sains</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A5.1</b>  | Menguasai konsep ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan/ Kedokteran Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif ditingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. |
| <b>A5.2</b>  | Menguasai prinsip pengelolaan masalah kesehatan berbasis bukti.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A5.3</b>  | Mengevaluasi data, argumen dan bukti secara ilmiah, serta menarik kesimpulan ilmiah.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A5.4</b>  | Menafsirkan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis.                                                                                                                                                                                                |
| <b>A5.7</b>  | Menguasai prinsip-prinsip ilmu Kedokteran Klinik.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AK2.2</b> | <b>Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>A6.1</b>  | Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan efektif untuk memperoleh informasi, menafsirkan hasil dan menilai mutu suatu informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran sepanjang hayat.                                                               |
| <b>A6.2</b>  | Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan civitas academica dan masyarakat umum                                                                                                                                                           |
| <b>A6.3</b>  | Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan materi dan mendiseminasikan secara efektif.                                                                                                                                                                               |

|             |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A6.4</b> | Mencari, mengambil, membuka dan membaca informasi yang disajikan secara digital menggunakan teknologi komunikasi, dan memanfaatkannya untuk pengembangan kemampuan akademik |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kelompok Area Kompetensi 3

|               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AK3.1.</b> | <b>Pengelolaan Masalah Kesehatan dan Sumber Daya</b>                                                                                                                                                              |
| <b>A7.1</b>   | Menguasai konsep upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat.                                                                        |
| <b>A7.2</b>   | Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai Kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, etnis, dan budaya.        |
| <b>A7.6</b>   | Menginterpretasi data klinis dan data kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat, untuk perumusan diagnosis atau masalah kesehatan.                                                                   |
| <b>A7.7</b>   | Menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu.                                                                                                     |
| <b>A7.8</b>   | Menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan perubahan perilaku yang rasional dalam kondisi simulasi.                                                                                           |
| <b>A7.9</b>   | Menguasai prinsip konsultasi dan/atau rujukan sesuai dengan standar pelayanan medis.                                                                                                                              |
| <b>A7.10</b>  | Menguasai prinsip keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan tepat.                                                                                 |
| <b>AK3.2</b>  | <b>Keterampilan Klinis</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>A8.1</b>   | Menguasai cara melakukan diagnosis dan diagnosis banding masalah kesehatan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan interpretasi hasil, serta memperkirakan prognosis penyakit. |
| <b>A8.3</b>   | Melakukan prosedur klinis dalam bidang kedokteran sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya.                                                                                                             |
| <b>AK 3.3</b> | <b>Komunikasi efektif</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>A9.1</b>   | Berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan sensitif serta menunjukkan empati terhadap reaksi saat berkomunikasi dengan civitas academica dan masyarakat umum.                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A9.2</b>   | Menguasai konsep komunikasi efektif pada kondisi pasien dengan masalah mental atau keterbatasan fisik.                                                                                                                                  |
| <b>AK 3.4</b> | <b>Ulul Albab</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>11.2</b>   | Menunjukkan kepribadian dan sikap yang mencerminkan akhlak mulia sebagai seorang muslim dan mahasiswa                                                                                                                                   |
|               | Mensimulasikan cara memberi motivasi dan bimbingan ibadah pada pasien dengan kondisi khusus                                                                                                                                             |
| <b>11.3</b>   | Menguasai pemahaman mengenai konsep, substansi dan metodologi ilmu keislaman meliputi studi al-Qur'an dan Hadits, filsafat ilmu, teosofi, studi fiqh, dan sejarah peradaban Islam serta mampu mengintegrasikannya dalam ilmu kedokteran |
|               | Menjelaskan kaidah Islam terkait isu-isu kedokteran kontemporer yang berkembang di masyarakat                                                                                                                                           |
|               | Menjelaskan saintifikasi konsep Thibbun Nabawi dalam pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan                                                                                                                                       |
|               | Menguasai keterampilan berbahasa arab dalam komunikasi sehari-hari dan simulasi pelayanan kesehatan                                                                                                                                     |

## 2.2 Tujuan Pembelajaran Blok *Special Sense*

Tujuan pembelajaran Blok *Special Sense* adalah:

- Mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi, etiologi, faktor resiko, diagnosis banding, kriteria diagnosis yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tatalaksana, penyakit sistem indra sesuai level SNPPDI 2019
- Mahasiswa mengetahui dan memahami morfologi, sifat mikrobiologi, antigen, diagnosis laboratorium mikrobiologi, epidemiologi tentang bakteri yang menyerang sistem indra
- Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan isu etik dan menguasai solusi penyelesaian dilema etik di bidang pengindraan.
- Mahasiswa Mahasiswa mampu menggunakan ayat Quran maupun Hadits yang berkaitan dengan pengindraan dan atau memberikan penjelasan medis yang merujuk ayat Quran atau hadits untuk dijadikan

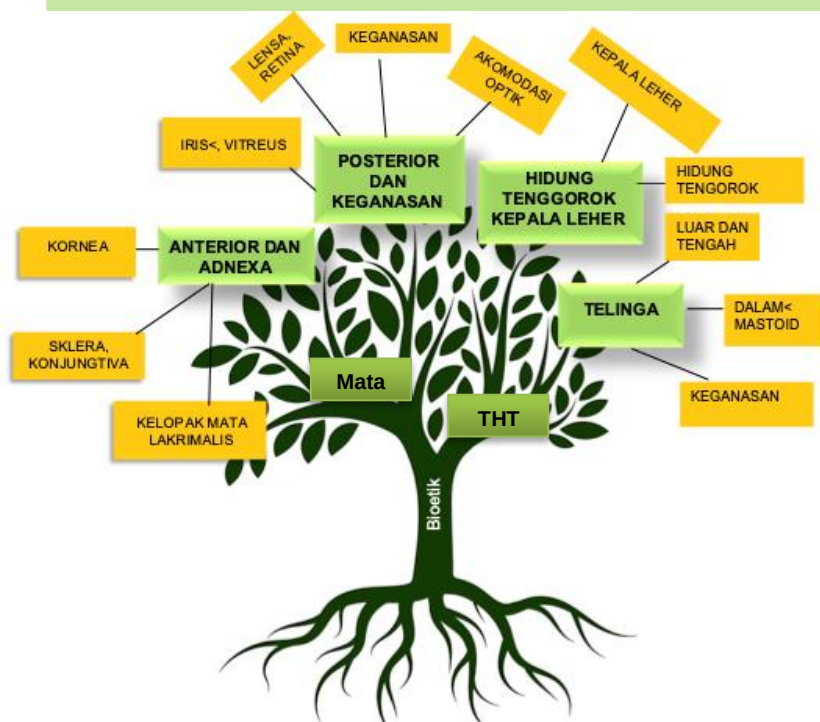
dasar dalam menambah keimanan dan dasar pelayananan medis berbasis Islam.

### III. METODE KEGIATAN BELAJAR

Pembelajaran dalam Blok *special sense* diberikan secara tematik. Empat tema yang diusung terdiri atas: (1) penyakit segmen anterior mata dan adnexa mata, (2) penyakit segmen posterior mata dan keganasan, (3) penyakit hidung dan kepala leher dan (4) Penyakit telinga. Pembelajaran yang digunakan haruslah menggunakan metode yang menstimulasi dan mendukung mahasiswa untuk bertanggungjawab terhadap proses pembelajarannya dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip penja-minan mutu, kebenaran ilmiah, persamaan, kemanusiaan dan manfaat.

Dalam mencapai tujuan pembelajarannya, pembelajaran menggunakan metode-metode kegiatan dengan proporsi besar pada *student active learning* yang bervariasi diantaranya adalah tutorial, TBL, kuliah interaktif *flipped classroom*, praktikum dan tugas terstruktur.

#### IV. POHON TOPIK



Gambar 4.1. Pohon Topik Blok *Special Sense*

## V. PENILAIAN

Penilaian mahasiswa menekankan prinsip *Assessment for Learning* bukan *assessment of learning* yang memiliki makna bahwa penilaian ditujukan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai kemampuan dirinya dalam mencapai tujuan pembelajaran, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan juga dalam menyusun strategi menuju proses pembelajaran tahap lanjutan ditinjau dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Penilaian belajar mahasiswa memiliki 5 pondasi yaitu validitas, reliabilitas, dampak edukasi, penerimaan serta fisibilitas. Dalam rangka mengakomodir lima fungsi tersebut maka disusunlah *blue print assessment Blok special sense* yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Metode Penilaian Blok *special sense*

| No. | Metode Penilaian  | Bobot       | S |   |   |
|-----|-------------------|-------------|---|---|---|
|     |                   |             | K | A | P |
| 1.  | MCQ (UAB)         | 60%         | V | - | - |
| 2.  | Tutorial          | 10%         | V | V | V |
|     | Diskusi           | -           | - | - | - |
|     | Laporan           | -           | - | - | - |
| 3.  | Praktikum         | 10%         | V | - | V |
|     | pre tes           | -           | - | - | - |
|     | laporan           | -           | - | - | - |
|     | responsi          | -           | - | - | - |
| 4.  | TBL               | 10%         | V | V | - |
|     | RAP               | -           | - | - | - |
|     | tAPP              | -           | - | - | - |
|     | Peer Assessment   | -           | - | - | - |
| 5.  | Tugas Terstruktur | 10%         | V | V | V |
|     | Laporan           | -           | - | - | - |
|     | Presentasi        | -           | - | - | - |
|     | <b>Total</b>      | <b>100%</b> |   |   |   |

S= dampak pada mahasiswa, K=kognitif, A=afektif, P=psikomotor

## VI. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                    |                           |                         |  |   |                                   |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----|
|  |   | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)<br>PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER<br>FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN<br>UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG                               |                           |                         |  |   | 2023                              |  |     |
| Identitas mata kuliah                                                             |   |                                                                                                                                                                                    |                           | Identitas dan validasi  |  |   | Nama                              |  | TTD |
| Kode mata kuliah                                                                  |   | :                                                                                                                                                                                  | 20070111C18               | Dosen pengembang RPS    |  | : | dr. Ermin Rachmawati,<br>M.Biomed |  |     |
| Nama mata kuliah                                                                  |   | :                                                                                                                                                                                  | Blok <i>Special Sense</i> |                         |  |   |                                   |  |     |
| Bobot mata kuliah (SKS)                                                           |   | :                                                                                                                                                                                  | 5 (lima)                  | Koordinator Mata Kuliah |  | : | dr. Alvi Milliana, M.<br>Biomed   |  |     |
| Semester                                                                          |   | :                                                                                                                                                                                  | 6                         |                         |  |   |                                   |  |     |
| Mata kuliah prasyarat                                                             |   | :                                                                                                                                                                                  | -                         | Ketua Program Studi     |  | : | dr. Tias PG, M.Biomed             |  |     |
|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                    |                           |                         |  |   |                                   |  |     |
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)                                                |   |                                                                                                                                                                                    |                           |                         |  |   |                                   |  |     |
| Kode CPL                                                                          |   |                                                                                                                                                                                    |                           | Unsur CPL               |  |   |                                   |  |     |
| CP 1                                                                              | : | Merumuskan alternatif keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada praktik kedokteran                                                                                          |                           |                         |  |   |                                   |  |     |
| CP 2                                                                              | : | melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, dan meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan.                                                 |                           |                         |  |   |                                   |  |     |
| CP 3                                                                              | : | Menerapkan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip, nilai dan etika yang berlaku                                                                                            |                           |                         |  |   |                                   |  |     |
| CP 5                                                                              | : | Menguasai konsep ilmu Kedokteran Klinik yang terkini untuk mengelola masalah sistem indra secara holistik dan komprehensif ditingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. |                           |                         |  |   |                                   |  |     |



|                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CP 6</b>                                    | : | Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan efektif untuk memperoleh informasi, menafsirkan hasil dan menilai mutu suatu informasi untuk pembelajaran Blok special sense                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CP 7</b>                                    | : | Menguasai konsep upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masalah kesehatan individu di yang berkaitan dengan sistem indra                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CP 9</b>                                    | : | Berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan sensitif serta menunjukkan empati terhadap reaksi saat berkomunikasi dengan civitas academica dalam forum ilmiah pembelajaran Blok special sense                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CP 11</b>                                   | : | Menguasai pemahaman mengenai konsep, substansi dan metodologi ilmu keislaman meliputi studi al-Qur'an dan Hadits, filsafat ilmu, teosofi, studi fiqh, dan sejarah peradaban Islam serta mampu mengintegrasikannya dalam ilmu kedokteran                                                                                                                                                               |
|                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b> | : | Mahasiswa mampu melakukan pengelolaan penyakit mata, telinga, hidung dan tenggorok sesuai level SNPPDI 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bahan Kajian Keilmuan</b>                   | : | Ilmu kesehatan mata, ilmu kesehatan THT, radiologi, farmakologi, fisiologi dan biokimia, anatomi dan histologi, patologi anatomi, mikrobiologi.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tim dosen</b>                               | : | Departemen Ilmu Biomedik (Histologi-Patologi Anatomi)<br>Departemen Ilmu Biomedik (Mikrobiologi-Parasitologi-Imunologi)<br>Departemen Ilmu Biomedik (Fisio-Farmako)<br>Departemen Ilmu kedokteran klinis (Radiologi)<br>Departemen Ilmu kedokteran klinis (Mata)<br>Departemen Ilmu kedokteran klinis (THT)                                                                                           |
| <b>Daftar Referensi</b>                        | : | Brooks, G.F., Carrol, K.C., Butel, J.S., Morse, S. A., Mietzner, T.A., 2012. Mikrobiologi Kedokteran Jawetz, Melnick & Adelberg. EGC Edisi 25<br>Murray, Rosenthal, Pfaller. Medical Microbiology 7 <sup>th</sup> Edition. Elsevier Saunders<br>Goodman and Gilman. 2015. Dasar Farmakologi Terapi<br>Katzung, et al. 2015. Farmakologi Dasar dan Klinik<br>Olson, James. 2000. Clinical Pharmacology |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Kumar, Cotran, dan Robbins, 2013. Buku Ajar Patologi Edisi 9</p> <p>Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub. Division; 2011</p> <p>Bowling B. Kanski's Clinical ophthalmology: a systematic approach. London: Elsevier Health Sciences; 2016</p> <p>Harper RA. Basic ophthalmology. American Academy of Ophthalmology; 2010</p> <p>Artini W, Hutaaruk J, Yudisianil. Pemeriksaan dasar mata. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2011</p> <p>Ehlers JP, Shah CP, editors. The Wills eye manual: office and emergency room diagnosis and treatment of eye disease, 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams &amp; Wilkins; 2012</p> <p>Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala &amp; Leher Edisi ketujuh Editor: Efiaty Soepardi, Nurbaiti Iskandar, Jenny Bashiruddin, Ratna Dwi Restuti, 2012.</p> <p>Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008.</p> <p>Bailey's Head &amp; Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014.</p> <p>Boies Buku Ajar Penyakit THT Edisi 6 Editor: Adams Boies Highler, 2012.</p> <p>Current Diagnosis &amp; Treatment Otolaryngology Head and Neck Surgery, Third Edition Ed. Anil K. Lalwani, 2012.</p> <p>Diseases of Ear, Nose &amp; Throat, 6th Edition, PL Dhingra, 2013.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TABEL 3. RPS Blok *Special Sense***

| Kompetensi dasar                                              | Indikator                                                                                                                                                               | Pengalaman belajar                | Materi pokok                                                                                                                                                                        | Alokasi waktu | Bahan ajar                | Referensi                                                                                                                                     | Penilaian |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1: PENYAKIT SEGMENT ANTERIOR MATA DAN ADNEXA MATA</b> |                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                     |               |                           |                                                                                                                                               |           |
| Kuliah Kontrak Blok Special Sense                             | Mahasiswa mampu memahami strategi, metode, dan sistem penilaian Blok special sense                                                                                      | Kuliah sinkronous                 | Deskripsi dan tujuan pembelajaran blok<br>Matriks pembelajaran blok<br>Aturan blok<br>Penilaian blok                                                                                | 2x50 menit    | PPT                       | -                                                                                                                                             | -         |
| Bakteri pada sistem indra                                     | Mahasiswa mengetahui dan memahami morfologi, sifat mikrobiologi, antigen, diagnosis laboratorium mikrobiologi, epidemiologi tentang bakteri yang menyerang sistem indra | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | -<br>Bakteri intraselular obligat <ul style="list-style-type: none"> <li>o Rickettsia</li> <li>o Chlamydia</li> <li>o Ehrlichia</li> <li>o Anaplasma</li> <li>o Coxiella</li> </ul> |               | PPT<br>Video pembelajaran | Brooks, G.F., Carrol, K.C., Butel, J.S., Morse, S. A., Mietzner, T.A., 2012. Mikrobiologi Kedokteran Jawetz, Melnick & Adelberg. EGC Edisi 25 | MCQ-CBT   |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                        |                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penyakit kelopak mata         | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada kelopak mata | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trauma kelopak mata (kontusio, abrasi, avulsi, laserasi, rupture) 3A</li> <li>- Blefaritis 4</li> <li>- Herpes simpleks virus/zoster palpebra 3A</li> <li>- Hordeolum 4</li> <li>- Kalazion 3</li> <li>- Kelainan kongenital palpebra (epiblefaron, koloboma) 2</li> <li>- Hemangioma, port-wine stain 2</li> <li>- Xantelasma, nevus, papilloma, milia, keratoakantoma 2</li> <li>- Ptosis 3A</li> <li>- Lagofthalmos 3A</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | MCQ-CBT |
| Penyakit apparatus lakrimalis | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi, etiologi, faktor                                                                                                                                                                               | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Epikantus 3A</li> <li>- Kelainan tepi kelopak (ektropion, entropion) 3A</li> <li>- Trikiasis 4</li> <li>- Retraksi kelopak mata 3A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's                                                                                                        | MCQ-CBT |

|                                 |                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                        |                                                                                                        |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                 | resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan                                                                  |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laserasi ductus lakrimalis 3A</li> <li>- Dakriosistitis 3A</li> <li>- Obstruksi ductus nasolacrima 3A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        | General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 |         |
|                                 | penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada apparatus lakrimalis                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                        |                                                                                                        |         |
| Penyakit konjungtiva dan sklera | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan | Kuliah Asinkronus dan sinkronus | <p>Meliputi daftar penyakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benda asing di konjungtiva 4</li> <li>- Laserasi konjungtiva 3B</li> <li>- Perdarahan subkonjungtiva 4</li> <li>- Kemosis, folikel, papilla, flikten 2</li> <li>- Konjungtivitis (bakteri, viral, alergi) 4</li> <li>- Oftalmia neonatorum 3B</li> <li>- Pinguekula 2</li> <li>- Pterygium 3A</li> <li>- Mata kering 4</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange      | MCQ-CBT |

|                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |                                                                                                                                                         |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 | penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada konjungtiva dan sklera                                                                                                              |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Episkleritis 4</li> <li>- Skleritis 3A</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mata merah, gatal, berair, kering, nyeri, Lelah</li> <li>o Kotoran mata banyak</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        | medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011                                                                                                   |         |
| Penyakit Kornea | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <p>Meliputi daftar penyakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trauma kornea (abrasi, erosi) 3B</li> <li>- Luka bakar kimia dan termal 3B</li> <li>- Benda asing di kornea 3B</li> <li>- Perforasi/rupture kornea 3B</li> <li>- Keratitis (bakteri, virus, fungus, parasite) 3A</li> <li>- Ulkus kornea (bakteri, virus, fungus, parasite) 3B</li> <li>- Kerato-konjungtivitis sika 3A</li> <li>- Edema kornea 3A</li> <li>- Xeroftalmia 3A</li> <li>- Masalah kornea terkait lensa kontak 3B</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | MCQ-CBT |

|                                                 |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | penyakit pada kornea                                                                                                                                                          |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keratoconus, keratoglobus 2</li> <li>- Megalokornea, mikrokornea 1</li> <li>- Penglihatan kabur, ganda dan silau</li> </ul> |            |              |                                                                                                                                                         |                                                          |
| Melakukan proses tutorial secara kooperatif     | Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep pengelolaan penyakit segmen anterior mata dan adnexa mata secara berkelompok dengan menunjukkan sikap berpikir kritis dan kooperatif | Tutorial | Penyakit segmen anterior mata dan adnexa mata                                                                                                                        | 4x50 menit | Skenario     | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | Feedback<br><br>Diskusi tutorial<br><br>Laporan tutorial |
| Melakukan proses kolaborasi dalam menyelesaikan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami                                                                                                                                      | TBL      | Penyakit segmen anterior mata dan adnexa mata                                                                                                                        | 2X50 menit | Latihan soal | -                                                                                                                                                       | iRAT<br><br>tRAT                                         |

|                              |                                                                              |  |  |  |  |  |                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| permasalahan sesuai skenario | konsep penyakit dan tatalaksananya pada segmen anterior mata dan adnexa mata |  |  |  |  |  | Tapp<br>Peer assessment |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|

## TEMA 2: PENYAKIT SEGMENTER POSTERIOR MATA DAN KEGANASAN MATA

|                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penyakit lensa dan vitreus | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan | Kuliah Asinkronus dan sinkronus | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leukokoria 2</li> <li>- Katarak kongenital 2</li> <li>- Katarak senilis 3A</li> <li>- Afakia 3A</li> <li>- Pseudofakia 2</li> <li>- Dislokasi lensa 3A</li> <li>- Perdarahan vitreus 2</li> <li>- Endoftalmitis 3B</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | MCQ-CBT |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |                                                                                                                                                          |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                               | penyakit pada lensa dan vitreus                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |                                                                                                                                                          |         |
| Penyakit retina dan koroid                    | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada retina dan koroid | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komosis retina 2</li> <li>- Perdarahan retina 2</li> <li>- Oklusi pembuluh darah retina 2</li> <li>- Retinopati prematuritas 2</li> <li>- Retinopati diabetik 2</li> <li>- Retinopati hipertensi 2</li> <li>- Age-related macular degeneration 2</li> <li>- Macular hole 2</li> <li>- Makulopati toksik (obat) 2</li> <li>- Ablasio retina (serosa, regmatogen, traksional) 2</li> <li>- Uveitis posterior (CMV, HIV, toksoplasmosis, tuberkulosis dll) 2</li> <li>- Retinitis pigmentosa 2</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub. Division; 2011 | MCQ-CBT |
| Gangguan papil saraf optik dan persepsi visus | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi,                                                                                                                                                                                                     | Kuliah                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papiledema 2</li> <li>- Edema papil 2</li> <li>- Neuritis optik 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2x50 menit | PPT                    | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and                                                                                                                  | MCQ-CBT |

|                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |                                                                                                                 |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                          | etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari gangguan papil saraf optic dan persepsi visual | Asinkronus dan sinkronous        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropati optik (iskemik, binocular, toksik) 2</li> <li>- Atrofi papil optik 2</li> </ul>                                                                                                                                                                              |            | Video pembelajaran     | Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 |         |
| Gangguan persepsi visual | epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding,                                                                           | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Glaukoma akut 3B</li> <li>- Glaukoma lainnya (sudut terbuka, sudut tertutup, normotension) 3A</li> <li>- Diplopia monocular 2</li> <li>- Diplopia binocular 3A</li> <li>- Skotoma 2</li> <li>- Gangguan lapang pandang (hemianopia, glaucomatous changes) 2</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange               | MCQ-CBT |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |                                                                                                                                                         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                   | tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari gangguan persepsi visual                                                                                                                                                                     |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cortical visual impairment 1</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penglihatan kabur, ganda dan silau</li> <li>o Buta dan Buta warna</li> </ul> </li> </ul>                                                      |            |                        | medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011                                                                                                   |         |
| Kelainan refraksi | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan gangguan refraksi | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <p>Meliputi daftar penyakit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miopia ringan 4</li> <li>- Hipermetropia ringan 4</li> <li>- Astigmatisme ringan 4</li> <li>- Anisometropia dewasa 3A</li> <li>- Anisometropia anak 2</li> <li>- Presbiopia 4</li> <li>- Ambliopia 2</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | MCQ-CBT |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Penyakit orbita dan kedudukan bola mata | Mahasiswa mengetahui dan memahami Eeidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit orbita dan kedudukan bola mata | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selulitis (preseptal dan orbital) 2</li> <li>- Tiroid oftalmopati (retraksi kelopak mata) 3A</li> <li>- Mikroftalmos, kelainan kraniofasial 2</li> <li>- Atrofi bulbi (ptisis bulbi) 2</li> <li>- Trauma tumpul dan tajam 3B</li> <li>- Strabismus horizontal, vertikal 2</li> <li>- Nistagmus (kongenital, didapat, fisiologik) 1</li> <li>- Paralisis saraf kranial III, IV, VI 2</li> <li>- Miastenia gravis 2</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mata juling</li> </ul> </li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange Kuliah Asinkronous dan sinkronous medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | MCQ-CBT |
| Keganasan pada mata                     | Mahasiswa mengetahui dan memahami epidemiologi,                                                                                                                                                                                                             | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xantelasma, nevus, papilloma, milia,</li> <li>- keratoakantoma 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and                                                                                                                                                   | MCQ-CBT |

|  |                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan keganasan pada mata |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumor konjungtiva 2</li> <li>- Keganasan kelopak (karsinoma sel basal, karsinoma sel skuamosa, melanoma maligna, tumor metastatik) 2</li> <li>- Tumor iris 2</li> <li>- Retinoblastoma 2</li> <li>- Massa di retina (melanoma, limfoma, metastasis, dll) 1</li> <li>- Tumor jinak orbita (kista dermoid, neuroblastoma, meningioma) 1</li> <li>- Tumor ganas orbita (rabdomiosarkoma, leukemia, metastasis) 1</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mata terlihat seperti mata kucing</li> <li>o Mata terlihat menonjol</li> <li>o Mata terasa berpasir/mengganjal</li> </ul> </li> </ul> |  |  | Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                             |                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                              |                                                                                                                                                            |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pemeriksaan diagnostic dan tatalaksana mata | Mahasiswa mengetahui dan memahami tata cara pemeriksaan pada mata | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | Pemeriksaan diagnosis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeksi kornea dengan fluoresensi (3)</li> <li>- Pemeriksaan lensa kontak dengan komplikasi (3)</li> <li>- Peresepan kacamata pada kelainan refraksi ringan (sampai dengan 5D tanpa silindris) untuk mencapai visus 6/6 (3)</li> <li>- Peresepan kacamata baca pada penderita dengan visus jauh normal atau dapat dikoreksi menjadi 6/6 (4)</li> <li>- Flood ocular tissue (3)</li> <li>- Tekanan intra ocular, pengukuran dengan aplanasi tonometer atau non-contact-tonometer 2</li> <li>- Perimetri 2</li> <li>- Pengukuran produksi air mata 2</li> </ul> Tatalaksana pada mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melepaskan lensa kontak dengan komplikasi (3)</li> </ul> | 2x50 menit | PPT<br>Video<br>pembelajaran | Riordan-Eva P, Whitcher JP.<br>Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | MCQ-CBT |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                             |                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |                                                                                                                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                   |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melepaskan protesa mata 2</li> <li>- Mencabut bulu mata (4)</li> <li>- Membersihkan benda asing dan debris di konjungtiva (4)</li> <li>- Membersihkan benda asing dan debris di kornea tanpa komplikasi (3)</li> <li>- operasi katarak 2</li> </ul> |            |          |                                                                                                                                                         |                                                          |
| Melakukan proses tutorial secara kooperatif | Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep pengelolaan penyakit segmen posterior mata dan keganasan mata secara berkelompok dengan menunjukkan sikap berpikir kritis dan kooperatif | Tutorial | Penyakit segmen posterior mata dan keganasan mata                                                                                                                                                                                                                                            | 4x50 menit | Skenario | Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | Feedback<br><br>Diskusi tutorial<br><br>Laporan tutorial |

|                                                                              |                                                                                                                                 |     |                                                        |            |              |   |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|--------------|---|-----------------------------------------|
| Melakukan proses kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan sesuai skenario | Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep penyakit dan tatalaksana penyakit pada segmen posterior mata dan keganasan mata | TBL | Penyakit pada segmen posterior mata dan keganasan mata | 2X50 menit | Latihan soal | - | iRAT<br>tRAT<br>Tapp<br>Peer assessment |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|--------------|---|-----------------------------------------|

### TEMA 3: PENYAKIT HIDUNG, TENGGOROK DAN KEPALA LEHER

|                                    |                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        |                                                                                                                 |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Patomekanisme gangguan pada hidung | Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami patomekanisme gangguan pada hidung | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telinga nyeri/ sakit</li> <li>- Keluar cairan dari liang telinga</li> <li>- Telinga gatal</li> <li>- Telinga berdenging</li> <li>- Telinga terasa penuh</li> <li>- Telinga gatal</li> <li>- Gangguan pembauan</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008. | MCQ-CBT |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



|                                         |                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |                                                                                                                                      |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                         |                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        | Bailey's Head & Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014.                                  |         |
| Pemeriksaan dan tatalaksana pada THT-KL | Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pemeriksaan dan tatalaksana pada THT-KL | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan audiometri</li> <li>- Interpretasi hasil Audiometri – tone &amp; speech audiometry 3</li> <li>- Otoscopy pneumatic (Siegle) 2</li> <li>- Memeriksa dan menginterpretasi hasil timpanometri 2</li> <li>- Pemeriksaan vestibular sederhana 4</li> <li>- Tes Ewing 2</li> <li>- Pemeriksaan Kuantitatif Penghidu 2</li> <li>- Nasofaringoskopi 2</li> <li>- Penilaian pengecap 4</li> <li>- Pemasangan tampon posterior 3</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008. Bailey's Head & Neck | MCQ-CBT |

|                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |                                                                                                                                                                       |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              | Surgery<br>Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014.                                                                                     |         |
| Penyakit Hidung | Mahasiswa mengetahui dan memahami etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit sistem perhidu | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deviasi septum hidung 2</li> <li>- Furunkel pada hidung 4A</li> <li>- Rhinitis akut 4A</li> <li>- Rhinitis vasomotor 4A</li> <li>- Rhinitis alergika 4A</li> <li>- Rhinitis kronik 3A</li> <li>- Rhinitis medikamentosa 3A</li> <li>- Benda asing 4A</li> <li>- Epistaksis 4A</li> <li>- Pemasangan tampon posterior 3</li> <li>- Polip 2</li> <li>- Fraktur nasal 3A</li> </ul> | 2x50 menit | PPT<br>Video<br>pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008. Bailey's Head & Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. | MCQ-CBT |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                  | Bayley MD<br>FACS and<br>JonasT.<br>Johnson MD.<br>2014.                                                                                                                                                                                                      |         |
| Penyakit sinus<br>hidung | Mahasiswa<br>mengetahui dan<br>memahami<br>etiologi, faktor<br>risiko, kriteria<br>diagnosis meliputi<br>anamnesis,<br>pemeriksaan fisik<br>dan pemeriksaan<br>penunjang,<br>diagnosis<br>banding,<br>tatalaksana,<br>komplikasi,<br>pencegahan<br>penyakit yang<br>berkaitan dengan<br>sinus hidung | Kuliah<br>Asinkrono<br>us dan<br>sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinusitis akut 4A</li> <li>- Sinusitis frontal akut 2</li> <li>- Sinusitis maksilaris akut 3A</li> <li>- Sinusitis kronik 3A</li> <li>- Bilas sinus/ sinus lavage /pungsi sinus 2</li> <li>- Etmoiditis akut 1</li> <li>- Tumor sinonasal 2</li> </ul> | 2x50<br>menit | PPT<br>Video<br>pembelaja<br>ran | Scott-<br>Brown's<br>Otorhinolary<br>ngology:<br>Head and<br>Neck Surgery<br>7 Ed. Edited<br>by Michael J<br>Gleeson, Ray<br>C Clarke,<br>2008.<br>Bailey's<br>Hea<br>d & Neck<br>Surgery<br>Otolaryngolo<br>gy. Byron J.<br>Bayley MD<br>FACS and<br>JonasT. | MCQ-CBT |

|                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        |                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        | Johnson MD. 2014.                                                                                                                                                                                                     |         |
| Penyakit tenggorok | Mahasiswa mengetahui dan memahami etiologi, faktor risiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit tenggorok | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faringitis akut 4A</li> <li>- Faringitis kronik 3A</li> <li>- Tonsilitis akut 4A</li> <li>- Tonsilitis kronik 3A</li> <li>- Laringitis akut 4A</li> <li>- Laringitis kronik 3A</li> <li>- Hipertrofi adenoid 2</li> <li>- Abses uctusellar 3A</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008.<br>Bailey's Head & Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and JonasT. Johnson MD. 2014. | MCQ-CBT |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gangguan pada Kepala dan Leher | Mahasiswa mengetahui dan memahami etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan gangguan pada kepala dan leher | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fistula dan kista brankial lateral dan medial 2</li> <li>- Higroma kistik 2</li> <li>- Tortikolis 3A</li> <li>- Tumor colli 2</li> <li>- Abses Bezold 3A</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008. Bailey's Head & Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014. | MCQ-CBT |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                             |                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                           |                                                                                                  |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Radiologi sistem indra                      | Mahasiswa mengetahui dan memahami pemeriksaan tambahan radiologi yang berkaitan dengan system indra | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran pencitraan kondisi normal foto rontgen mata dan THT-KL</li> <li>- Gambaran pencitraan penyakit mata dan THT-KL: <ul style="list-style-type: none"> <li>o USG</li> <li>o Rontgen</li> <li>o CT scan</li> </ul> </li> <li>- Pemeriksaan Radiologi sinus 2</li> <li>- Interpretasi radiologi sinus 3</li> </ul> | 2x50 menit | PPT<br>Video pembelajaran | Sutton, D. (2005). <i>A textbook of radiology and imaging</i> . Edinburgh: Churchill Livingstone | MCQ-CBT                   |
| Farmakologi penginderaan                    | Mahasiswa mengetahui dan memahami                                                                   | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obat-obatan topikal untuk kelainan mata dan THT-KL meliputi:</li> <li>- Analgetik antiinflamasi</li> <li>- Steroid</li> <li>- anestesi local</li> <li>- Antimikroba</li> <li>- Antiseptik</li> </ul>                                                                                                                  | 2x50 menit | PPT<br>Video pembelajaran |                                                                                                  | MCQ-CBT                   |
| Melakukan proses tutorial secara kooperatif | Mahasiswa mengetahui dan memahami                                                                   | Tutorial                          | Penyakit hidung, tenggorok dan kepala leher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4x50 menit | Skenario                  | Riordan-Eva P, Whitcher JP.                                                                      | Feedback Diskusi tutorial |

|                                 |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                 | konsep pengelolaan penyakit hidung, tenggorok dan kepala leher secara berkelompok dengan menunjukkan sikap berpikir kritis dan kooperatif |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                        | Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011 | Laporan tutorial |
| Melakukan literasi ilmiah       | Journal reading                                                                                                                           | Tugas terstruktur                 | <b>Kel 1 dan 2</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 2x50 menit | -                      | -                                                                                                                           | Journal reading  |
| <b>TEMA 4: PENYAKIT TELINGA</b> |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |                                                                                                                             |                  |
| Penyakit Telinga Luar           | Mahasiswa mengetahui dan memahami etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi                                                    | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inflamasi pada aurikuler 3A</li> <li>- Herpes zoster pada telinga 3A</li> <li>- Fistula pre-aurikuler 3A</li> <li>- Otitis eksterna 4A</li> <li>- Benda asing 3B</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery                                                                    | MCQ-CBT          |

|                                     |                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |                                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                     | anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis                                                                   |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolesteatoma 2</li> <li>- Serumen prop 4A</li> <li>- Trauma aurikuler 3B</li> <li>- Kelainan aurikuler kongenital 2</li> <li>- Pemasangan tampon telinga 4</li> </ul>                                                                                                            |            |                        | 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008. Bailey's Head & Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014. |         |
| Penyakit Telinga Tengah dan Mastoid | Mahasiswa mengetahui dan memahami etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan | Kuliah Asinkronous dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otitis media akut 4A</li> <li>- Otitis media serosa 3A</li> <li>- Otitis media kronik 3A</li> <li>- Inseri grommet tube 1</li> <li>- Mastoiditis 3A</li> <li>- Miringitis bullosa 3A</li> <li>- Perforasi uctuse timpani 3A</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray                                                            | MCQ-CBT |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                              |                                                                                                                                                |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                           | penunjang,<br>diagnosis<br>banding,<br>tatalaksana,<br>komplikasi,<br>pencegahan dari<br>penyakit telinga<br>tengah dan<br>mastoid                                                                 |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otosklerosis 3A</li> <li>- Timpanosklerosis 2</li> </ul>                                                                                                                                                                          |            |                              | C Clarke,<br>2008.<br>Bailey's<br>Head & Neck<br>Surgery<br>Otolaryngology.<br>Byron J. Bayley MD<br>FACS and<br>Jonas T. Johnson MD.<br>2014. |         |
| Penyakit Telinga<br>Dalam dan<br>Gangguan<br>Keseimbangan | Mahasiswa<br>mengetahui dan<br>memahami<br>etiologi, faktor<br>resiko, kriteria<br>diagnosis meliputi<br>anamnesis,<br>pemeriksaan fisik<br>dan pemeriksaan<br>penunjang,<br>diagnosis<br>banding, | Kuliah<br>Asinkronus<br>dan<br>sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuli (kongenital, perseptif, konduktif) 2</li> <li>- Labirintitis 2</li> <li>- Presbiakusis 3A</li> <li>- Trauma akustik akut 3A</li> <li>- Menyesuaikan alat bantu dengar 2</li> </ul> | 2x50 menit | PPT<br>Video<br>pembelajaran | Scott-Brown's<br>Otorhinolaryngology:<br>Head and<br>Neck Surgery<br>7 Ed. Edited<br>by Michael J<br>Gleeson, Ray<br>C Clarke,<br>2008.        | MCQ-CBT |

|                  |                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                        |                                                                                                                                      |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari Penyakit Telinga Dalam dan Gangguan Keseimbangan                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                        | Bailey's Head & Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014.                                  |         |
| Keganasan THT-KL | Mahasiswa mengetahui dan memahami etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi dari | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | Meliputi daftar penyakit sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ca nasofaring (Karsinoma nasofaring 2)</li> <li>- Ca hidung dan sinus paranasalis (Tumor sinonasal 2)</li> <li>- Ca laring (Karsinoma laring 2)</li> <li>- Ca telinga</li> <li>- Tumor colli 2</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008. Bailey's Head & Neck | MCQ-CBT |

|                           |                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        |                                                                                                                                                                                                                  |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                           | Keganasan pada THT-KL                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        | Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014.                                                                                                                                   |         |
| PA Keganasan sistem indra | Mahasiswa mengetahui dan memahami Gambaran PA keganasan pada mata dan THT-KL | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | Gambaran PA makros dan mikros keganasan pada mata dan THT-KL-KL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keganasan intraorbita</li> <li>- Keganasan ekstraorbita</li> <li>- Ca nasofaring</li> <li>- Ca hidung dan sinus paranasalis</li> <li>- Ca laring</li> <li>- Ca telinga</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran | O'Dowd, G., Bell, S., & Wright, S. (2020). <i>Wheater's pathology: A text, atlas and review of histopathology</i> . Robbins, S. L., Aster, J. C., Perkins, J. A., Abbas, A. K., & Kumar, V. (2018). <i>Robbi</i> | MCQ-CBT |

|                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |                                                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        | <i>ns basic pathology. Philadelphia: Elsevier</i> |                                            |
| Bioetik yang berkaitan dengan sistem indra (hak-hak orang cacat) | Mahasiswa mengetahui dan memahami isu etik yang berkaitan dengan sistem indra                   | Kuliah Asinkronus dan sinkronous | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk orang cacat</li> <li>- Identifikasi isu etik dalam konteks hak untuk orang cacat</li> <li>- Mengenali dan membedakan isu etik terkait hak untuk orang cacat dari isu yang lain</li> <li>- Empat dasar prinsip etik pada kasus tentang hak untuk orang cacat</li> <li>- Pertimbangan rasional untuk keputusan etik tentang hak untuk orang cacat</li> </ul> | 2x50 menit | PPT Video pembelajaran |                                                   | MCQ-CBT                                    |
| Melakukan proses tutorial secara kooperatif                      | Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep pengelolaan penyakit telinga secara berkelompok dengan | Tutorial                         | Penyakit telinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4x50 menit | Skenario               |                                                   | Feedback Diskusi tutorial Laporan tutorial |

|                                                                              |                                                                                                |                   |                                                                        |            |                          |   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---|--------------------------------------------|
|                                                                              | menunjukkan sikap berpikir kritis dan kooperatif                                               |                   |                                                                        |            |                          |   |                                            |
| Melakukan proses kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan sesuai skenario | Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep penyakit dan tatalaksana pada penyakit telinga | TBL               | Penyakit pada telinga                                                  | 2X50 menit | Latihan soal             | - | iRAT<br>tRAT<br>Tapp<br>Peer<br>assessment |
| Praktikum PA Sistem Indra                                                    | Mengetahui dan menjelaskan gambaran PA pada sistem indra                                       | Praktikum         | Mengidentifikasi gambaran patologis pada sediaan preparat sistem indra | 4x50 menit | Petunjuk praktikum video | - | Pretest<br>Laporan praktikum<br>Responsi   |
| Melakukan literasi ilmiah                                                    | Journal reading                                                                                | Tugas terstruktur | <b>Kel 3 dan 4</b>                                                     | 2x50 menit | -                        | - | Journal reading                            |

## VII. REKAP PEMBELAJARAN

### TEMA 1: PENYAKIT SEGMENT ANTERIOR MATA DAN ADNEXA MATA

Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis Tema 1

Tabel 7.1.1 Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis

Tema 1

| DAFTAR MASALAH                                                                                                                                                | DAFTAR PENYAKIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DAFTAR KETERAMPILAN KLINIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata merah<br>Mata gatal<br>Mata berair<br>Mata kering<br>Mata nyeri<br>Mata ucu<br>Kotoran mata<br>Bintik di kelopak mata<br>Kelilipan (benda asing di mata) | Blefaritis 4A<br>Hordeolum 4A<br>Chalazion 3A<br>Laserasi kelopak mata 3B<br>Entropion 2<br>Trikiasis 4A<br>Lagoftalmus 2<br>Epikantus 2<br>Ptosis 2<br>Retraksi kelopak mata 2<br>Xanthelasma 2<br>Dakrioadenitis 3A<br>Dakriosistitis 3A<br>Dakriostenosis 2<br>Laserasi uctus lakrimal 2<br>Benda asing di konjungtiva 4A<br>Pterigium 3A<br>Konjungtivitis 4A<br>Perdarahan subkonjungtiva 4A<br>Mata kering 4A<br>Skleritis 3A<br>Episkleritis 4A<br>Erosi kornea 2<br>Benda asing di kornea 2<br>Luka bakar kornea 2<br>Keratitis 3A<br>Kerato-konjungtivitis sicca 2 | Inspeksi kelopak mata 4<br>Inspeksi kelopak mata dengan eversi kelopak atas 4<br>Inspeksi bulu mata 4<br>Inspeksi konjungtiva, termasuk forniks 4<br>Inspeksi sclera 4<br>Inspeksi orifisium uctus lakrimalis 4<br>Palpasi limfonodus pre-aurikuler 4<br>Penilaian posisi dengan corneal reflex images (Hirschberg test) 4<br>Penilaian posisi dengan cover uncover test 4<br>Pemeriksaan gerakan bola mata 4<br>Penilaian penglihatan binocular 2<br>Inspeksi pupil 4<br>Penilaian pupil dengan reaksi langsung terhadap cahaya dan konvergensi 4<br>Inspeksi segmen anterior dengan transiluminasi (pen light) 4<br>Inspeksi kornea 4<br>Inspeksi kornea dengan fluoresensi 3<br>Tes sensitivitas kornea 4<br>Inspeksi bilik mata depan 4 |

|  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Edema kornea 2<br>Keratokonius 2<br>Xerophthalmia 3A<br>Hifema 3A<br>Hipopion 3A | Inspeksi iris 4<br>Inspeksi lensa 4<br>Pemeriksaan dengan slit-lamp 2<br>Eversi kelopak atas dengan kapas lidi (swab) untuk membersihkan benda asing non trauma 4<br>Pemasangan perban mata 4<br>Melepaskan lensa kontak dengan komplikasi 3<br>Melepaskan protesa mata 4<br>Mencabut bulu mata 4<br>Membersihkan benda asing dan debris di konjungtiva 4<br>Membersihkan benda asing dan debris di kornea tanpa komplikasi 3<br>Pemberian obat tetes mata 4<br>Aplikasi salep mata 4<br>Flood ocular tissue 3<br>Bedah kelopak mata ( <i>chalazion, entropion, ectropion, ptosis</i> ) 2 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kuliah Tema 1

Tabel 7.1. 2 Daftar Kuliah Tema 1

| No | Topik                     | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                                                     | Bidang Ilmu/Dosen |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Kuliah kontrak blok       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deskripsi dan tujuan pembelajaran blok</li> <li>- Matriks pembelajaran blok</li> <li>- Penilaian blok</li> </ul>                                                                                         | Ko Blok/VI        |
| 2. | Bakteri pada sistem indra | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakteri intraselular obligat               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Rickettsia</li> <li>o Chlamydia</li> <li>o Ehrlichia</li> <li>o Anaplasma</li> <li>o Coxiella</li> </ul> </li> </ul> | Mikro/VI          |
| 3  | Penyakit kelopak mata     | Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi,                                                                            | Mata/YUL          |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                 | <p>pencegahan penyakit pada kelopak mata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trauma kelopak mata (kontusio, abrasi, avulsi, laserasi, rupture) 3A</li> <li>- Blefaritis 4</li> <li>- Herpes simpleks virus/zoster palpebra 3A</li> <li>- Hordeolum 4</li> <li>- Kalazion 3</li> <li>- Kelainan kongenital palpebra (epiblefaron, koloboma) 2</li> <li>- Hemangioma, port-wine stain 2</li> <li>- Xantelasma, nevus, papilloma, milia, keratoakantoma 2</li> <li>- Ptosis 3A</li> <li>- Lagofthalmos 3A</li> </ul>             |          |
| 4. | Penyakit apparatus lakrimalis   | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada apparatus lakrimalis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Epikantus 3A</li> <li>- Kelainan tepi kelopak (ektropion, entropion) 3A</li> <li>- Trikiasis 4</li> <li>- Retraksi kelopak mata 3A</li> <li>- Laserasi ductus lakrimalis 3A</li> <li>- Dakriosistitis 3A</li> <li>- Obstruksi ductus nasolacrimonal 3A</li> </ul> | Mata/YUL |
| 5  | Penyakit konjungtiva dan sklera | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada konjungtiva dan sklera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benda asing di konjungtiva 4</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | Mata/YUL |



|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laserasi konjuntiva 3B</li> <li>- Perdarahan subkonjuntiva 4</li> <li>- Kemosis, folikel, papilla, flikten 2</li> <li>- Konjungtivitis (bakteri, viral, alergi) 4</li> <li>- Oftalmia neonatorum 3B</li> <li>- Pinguekula 2</li> <li>- Pterygium 3A</li> <li>- Mata kering 4</li> <li>- Episkleritis 4</li> <li>- Skleritis 3A</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mata merah, gatal, berair, kering, nyeri, Lelah</li> <li>o Kotoran mata banyak</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                               |          |
| 6. | Penyakit Kornea                  | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada kornea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trauma kornea (abrasi, erosi) 3B</li> <li>- Luka bakar kimia dan termal 3B</li> <li>- Benda asing di kornea 3B</li> <li>- Perforasi/rupture kornea 3B</li> <li>- Keratitis (bakteri, virus, fungus, parasite) 3A</li> <li>- Ulkus kornea (bakteri, virus, fungus, parasite) 3B</li> <li>- Kerato-konjungtivitis sika 3A</li> <li>- Edema kornea 3A</li> <li>- Xeroftalmia 3A</li> <li>- Masalah kornea terkait lensa kontak 3B</li> <li>- Keratoconus, keratoglobus 2</li> <li>- Megalokornea, mikrokornea 1</li> </ul> | Mata/YUL |
| 7. | Penyakit bilik mata depan, iris, | Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mata/YUL |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | pupil, dan badan siliar | <p>pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada iris, badan siliar, cairan vitreus dan bola mata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hifema 3A</li> <li>- Hipopion 3A</li> <li>- Uveitis anterior 2</li> <li>- Iridodialisis 2</li> <li>- Iridosiklitis, iritis 3A</li> <li>- Kelainan kongenital iris (aniridia, koloboma) 2</li> <li>- Tumor iris 2</li> <li>- Anisokoria 2</li> <li>- Leukokoria 2</li> <li>- Katarak kongenital 2</li> <li>- Katarak senilis 3A</li> </ul> |  |
|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Skenario Tema 1

“Mataku belekan yang bikin insecure...”

Tn S berumur 25 tahun, datang ke Puskesmas dengan keluhan mata kanan belekan sejak 3 hari yang lalu. Tn S juga disertai mata merah, lengket saat bangun tidur, berair, mengganjal tetapi penglihatan masih jelas. Belekan sangat mengganggu sekali karena berwarna kuning dan berbau sehingga membuat tidak percaya diri. Pasien sudah mencuci dengan air rebusan sirih tetapi malah bertambah parah. Seminggu yang lalu pasien kebut – kebutan di jalan berdebu tanpa kacamata. Beberapa teman kantor menjauhi kontak mata dengan Tn. S yang membuat insecure

Pada pemeriksaan didapatkan: VOD 6/6, kemosis konjungtiva, injeksi konjungtiva dan pericorneal injeksi (-), didapatkan secret warna kuning serta kornea jernih. Tidak ditemukan pembesaran limfonodi pre auricular

mata kiri dalam batas normal

## TBL

Dosen : YUL

### TEMA 2: PENYAKIT SEGMENT POSTERIOR MATA DAN KEGANASAN MATA

#### Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis Tema 2

Tabel 7.2.1 Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis Tema 2

| DAFTAR MASALAH                                                       | DAFTAR PENYAKIT                                   | DAFTAR KETERAMPILAN KLINIS                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Penglihatan kabur                                                    | Iridosisklitis, iritis 3A                         | Penilaian ketajaman penglihatan 4                                                       |
| Penglihatan ganda                                                    | Tumor iris 2                                      | Penilaian penglihatan, bayi dan anak 3                                                  |
| Penglihatan silau                                                    | Perdarahan Vitreous 1                             | Penilaian refraksi, subjektif 4                                                         |
| Gangguan lapangan pandang                                            | Endoftalmitis 2                                   | Penilaian refraksi, objektif (refractometry keratometer) 2                              |
| Buta                                                                 | Mikroftalmos 2                                    | Lapang Pandang 4                                                                        |
| Masalah akibat penggunaan lensa kontak                               | Katarak 2                                         | Lapang pandang (confrontation test) 4                                                   |
| Mata juling                                                          | Afakia kongenital 2                               | Lapang pandang, Amsler grid 3                                                           |
| Mata terlihat seperti mata kucing/ orang-orangan mata terlihat putih | Dislokasi lensa 2                                 | Fundoscopy untuk melihat fundus reflex 4                                                |
|                                                                      | Ablasio retina 2                                  | Fundoscopy untuk melihat pembuluh darah, papil, macula 4                                |
|                                                                      | Perdarahan retina, oklusi pembuluh darah retina 2 | Tekanan intra okular, estimasi dengan palpasi 4                                         |
|                                                                      | Degenerasi makula karena usia 2                   | Tekanan intra okular, pengukuran dengan indentasi tonometer (Schiötz) 4                 |
|                                                                      | Retinopati (diabetik, hipertensi, prematur) 2     | Tekanan intra okular, pengukuran dengan aplanasi tonometer atau non-contact-tonometer 2 |
|                                                                      | Korioretinitis 1                                  | Penentuan refraksi setelah sikloplegia (skiascopy) 1                                    |
|                                                                      | <i>Optic disc cupping</i> 2                       | Pemeriksaan lensa kontak fundus, mis. gonioscopy 1                                      |
|                                                                      | Hipermetropia ringan 4A                           | Pengukuran produksi air mata 2                                                          |
|                                                                      | Miopia ringan 4A                                  |                                                                                         |
|                                                                      | Astigmatism ringan 4A                             |                                                                                         |
|                                                                      | Presbiopia 4A                                     |                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Anisometropia pada dewasa 3A<br>Anisometropia pada anak 2<br>Ambliopia 2<br>Diplopia binokuler 2<br>Buta senja 4A<br>Skotoma 2<br>Hemianopia, bitemporal, and homonymous 2<br>Gangguan lapang pandang 2<br>Keganasan mata<br>Glaukoma akut 3B<br>Glaukoma lainnya 3A<br>Edema papil 2<br>Atrofi optik 2<br>Neuropati optik 2<br>Neuritis optik 2 | Pengukuran exophthalmos (Hertel) 2<br>Pembilasan melalui saluran lakrimalis (Anel) 2<br>Pemeriksaan orthoptic 2<br>Perimetri 2<br>Pemeriksaan lensa kontak dengan komplikasi 3<br>Tes penglihatan warna (dengan buku Ishihara 12 plate) 4<br>Elektoretinografi 1<br>Electro-oculography 1<br>Visual evoked potentials (VEP/ VER) 1<br>Fluorescein angiography (FAG) 1<br>Echographic examination: ultrasonography (USG) 1<br>Pereseapan kacamata pada kelainan refraksi ringan (sampai 5D tanpa silendris) untuk mencapai visus 6/6 3<br>Pereseapan kacamata baca pada penderita dengan visus jauh normal atau bisa dikoreksi menjadi 6/6 4<br>Terapi laser 1<br>Operasi katarak 2<br>Operasi strabismus 1<br>Vitrektomi 1<br>Operasi glaukoma dengan trabekulotomi 1<br>Transplantasi kornea 1<br>Cryocoagulation: mis. Cyclocryocoagulation 1<br>Operasi detached retina 1 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kuliah Tema 2

Tabel 7.2. 2 Daftar Kuliah Tema 2

| No | Topik                      | Pokok Bahasan                                             | Bidang Ilmu/Dosen |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Penyakit lensa dan vitreus | Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis | Mata/YUL          |

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                                                | <p>meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan</p> <p>penyakit pada iris, badan silier, cairan vitreus dan bola mata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leukokoria 2</li> <li>- Katarak kongenital 2</li> <li>- Katarak senilis 3A</li> <li>- Afakia 3A</li> <li>- Pseudofakia 2</li> <li>- Dislokasi lensa 3A</li> <li>- Perdarahan vitreus 2</li> <li>- Endoftalmitis 3B</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2 | Penyakit Retina dan Koroid                     | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan</p> <p>penyakit pada lensa dan retina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komosio retina 2</li> <li>- Perdarahan retina 2</li> <li>- Oklusi pembuluh darah retina 2</li> <li>- Retinopati prematuritas 2</li> <li>- Retinopati diabetik 2</li> <li>- Retinopati hipertensi 2</li> <li>- Age-related macular degeneration 2</li> <li>- Macular hole 2</li> <li>- Makulopati toksik (obat) 2</li> <li>- Ablasio retina (serosa, regmatogen, traksional) 2</li> <li>- Uveitis posterior (CMV, HIV, toksoplasmosis, tuberkulosis dll) 2</li> <li>- Retinitis pigmentosa 2</li> </ul> | Mata/YUL |
| 3 | Penyakit papil saraf optic dan persepsi visual | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mata/YUL |

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                          | <p>pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan gangguan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papiledema 2</li> <li>- Edema papil 2</li> <li>- Neuritis optik 2</li> <li>- Neuropati optik (iskemik, binocular, toksik) 2</li> <li>- Atrofi papil optik 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 4 | Gangguan persepsi visual | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan gangguan persepsi visual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Glaukoma akut 3B</li> <li>- Glaukoma lainnya (sudut terbuka, sudut tertutup, normotension) 3A</li> <li>- Diplopia monocular 2</li> <li>- Diplopia binocular 3A</li> <li>- Skotoma 2</li> <li>- Gangguan lapang pandang (hemianopia, glaucomatous changes) 2</li> <li>- Cortical visual impairment 1</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penglihatan kabur, ganda dan silau</li> <li>o Buta dan Buta warna</li> </ul> </li> </ul> | Mata/YUL |
| 5 | Kelainan refraksi        | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit pada kelainan refraksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miopia ringan 4</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mata/YUL |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hipermetropia ringan 4</li> <li>- Astigmatisme ringan 4</li> <li>- Anisometropia dewasa 3A</li> <li>- Anisometropia anak 2</li> <li>- Presbiopia 4</li> <li>- Ambliopia 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 6. | Penyakit orbita dan kedudukan bola mata | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan penyakit orbita dan kedudukan bola mata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selulitis (preseptal dan orbital) 2</li> <li>- Tiroid oftalmopati (retraksi kelopak mata) 3A</li> <li>- Mikroftalmos, kelainan kraniofasial 2</li> <li>- Atrofi bulbi (ptosis bulbi) 2</li> <li>- Trauma tumpul dan tajam 3B</li> <li>- Strabismus horizontal, vertikal 2</li> <li>- Nistagmus (kongenital, didapat, fisiologik) 1</li> <li>- Paralisis saraf kranial III, IV, VI 2</li> <li>- Miastenia gravis 2</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mata juling</li> </ul> </li> </ul> | Mata/YUL |
| 7. | Keganasan pada mata                     | <p>Epidemiologi, etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan keganasan mata :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mata/YUL |

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xantelasma, nevus, papilloma, milia,</li> <li>- keratoakantoma 2</li> <li>- Tumor konjungtiva 2</li> <li>- Keganasan kelopak (karsinoma sel basal, karsinoma sel skuamosa, melanoma maligna, tumor metastatik) 2</li> <li>- Tumor iris 2</li> <li>- Retinoblastoma 2</li> <li>- Massa di retina (melanoma, limfoma, metastasis, dll) 1</li> <li>- Tumor jinak orbita (kista dermoid, neuroblastoma, meningioma) 1</li> <li>- Tumor ganas orbita (rabdomiosarkoma, leukemia, metastasis) 1</li> <li>- Patomekanisme gangguan pada mata:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mata terlihat seperti mata kucing</li> <li>o Mata terlihat menonjol</li> <li>- Mata terasa berpasir/mengganjal</li> </ul> </li> </ul> |          |
| 8 | Pemeriksaan diagnostik dan Tatalaksana pada Mata | Pemeriksaan diagnosis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeksi kornea dengan fluoresensi (3)</li> <li>- Pemeriksaan lensa kontak dengan komplikasi (3)</li> <li>- Peresepan kacamata pada kelainan refraksi ringan (sampai dengan 5D tanpa silindris) untuk mencapai visus 6/6 (3)</li> <li>- Peresepan kacamata baca pada penderita dengan visus jauh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mata/YUL |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- normal atau dapat dikoreksi menjadi 6/6 (4)</li> <li>- Flood ocular tissue (3)</li> <li>- Tekanan intra ocular, pengukuran dengan applanasi tonometer atau non-contact-tonometer 2</li> <li>- Perimetri 2</li> <li>- Pengukuran produksi air mata 2</li> </ul> <p>Tatalaksana pada mata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melepaskan lensa kontak dengan komplikasi (3)</li> <li>- Melepaskan protesa mata 2</li> <li>- Mencabut bulu mata (4)</li> <li>- Membersihkan benda asing dan debris di konjungtiva (4)</li> <li>- Membersihkan benda asing dan debris di kornea tanpa komplikasi (3)</li> <li>- operasi katarak 2</li> </ul> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Skenario Tema 2

“Mataku kena santet”

Ny. M berusia 55 tahun dibawa ke IGD RS dengan keluhan mata kiri nyeri hebat sekitar jam 3 pagi. Pasien juga mengeluh mual dan muntah sampai mengikat kepalanya dengan sabuk. Mata kiri pasien juga tidak bisa melihat, silau, berair dan melihat Pelangi di sekitar sumber Cahaya. Pasien sebelumnya menggunakan kacamata s+400 untuk melihat jauh. Pasien percaya mata kirinya kena santet karena sebelumnya tidak mendadak dan tidak sembuh dengan obat skait kepala dan tetes mata

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan umum : kesakitan hebat dengan kepala diikat sabuk

Vital Sign : Nadi : 102x/menit, RR : 26x/menit, Suhu : 36,80 C,  
TD : 130/90 mmHg

Mata :

OD : VOD 6/6, lensa mata keruh tipis, COA dangkal , normal palpasi

OS : VOS 1/60, blefaropasme, mix injeksi konjungtiva , edem kornea , bilik mata depan kesan dangkal dangkal, pupil 6 mm, refleks pupil (-), lensa keruh tidak rata . tonometri n +2 palpasi

Pemeriksaan Laboratorium :

Darah rutin : Hb 12, 2 g/dL ; leukosit 8200/ mm<sup>3</sup>

Kimia darah : GDA 98 mg/dl

**TBL**

Dosen : YUL

## TEMA 3: PENYAKIT HIDUNG, TENGGOROK DAN KEPALA LEHER

### Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis Tema 3

Tabel 7.3.1 Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis Tema 1

| DAFTAR MASALAH                                                                                                                                                                                 | DAFTAR PENYAKIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DAFTAR KETERAMPILAN KLINIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gangguan pembauan<br>Bersin-bersin<br>Pilek (ingusan)<br>Mimisan<br>Hidung tersumbat<br>Hidung berbau Benda asing dalam hidung<br>Nyeri menelan<br>Suara serak<br>Suara sengau<br>Suara hilang | Deviiasi septum hidung 2<br>Furunkel pada hidung 4A<br>Rhinitis akut 4A<br>Rhinitis vasomotor 4A<br>Rhinitis alergika 4A<br>Rhinitis kronik 3A<br>Rhinitis medikamentosa 3A<br>Sinusitis akut 4A<br>Sinusitis frontal akut 2<br>Sinusitis maksilaris akut 3A<br>Sinusitis kronik 3A<br>Etmoiditis akut 1<br>Polip 2<br>Tumor sinonasal 2<br>Benda asing hidung 4A<br>Epistaksis 4A<br>Fistula dan kista brankial lateral dan medial 2<br>Higroma kistik 2<br>Tumor colli 2<br>Tortikolis 3A<br>Abses Bezold 3A<br>Faringitis akut 4A<br>Faringitis kronik 3A<br>Tonsilitis akut 4A<br>Tonsilitis kronik 3A<br>Laringitis akut 4A<br>Laringitis kronik 3A<br>Hipertrofi adenoid 2<br>Abses peritonsilar 3A | Inspeksi bentuk hidung dan lubang hidung 4<br>Penilaian obstruksi hidung 4<br>Pemeriksaan Kuantitatif Penghidu 2<br>Rinoskopi anterior 4<br>Transluminasi sinus frontalis & maksila 4<br>Nasofaringoskopi 2<br>CT scan sinus 1<br>Radiologi sinus 2<br>Interpretasi radiologi sinus 3<br>Penilaian pengecap 4<br>Menghentikan perdarahan hidung anterior 4<br>Pengambilan benda asing dari hidung 3B<br>Bilas sinus/ sinus <i>lavage</i> /punksi sinus 2<br>Antroskopi 1<br>Pemasangan tampon posterior 3 |

|  |                                              |  |
|--|----------------------------------------------|--|
|  | Karsinoma laring 2<br>Karsinoma nasofaring 2 |  |
|--|----------------------------------------------|--|

### Kuliah Tema 3

Tabel 7.3. 2 Daftar Kuliah Tema 3

| NO | TOPIK                                       | POKOK BAHASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIDANG ILMU/<br>DOSEN |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Patomekanisme gangguan pada hidung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telinga nyeri/ sakit</li> <li>- Keluar cairan dari liang telinga</li> <li>- Telinga gatal</li> <li>- Telinga berdenging</li> <li>- Telinga terasa penuh</li> <li>- Telinga gatal</li> <li>- Gangguan pembauan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | THT/FJ                |
| 2. | Pemeriksaan dan tata laksana pada THT-KL-KL | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan audiometri</li> <li>- Interpretasi hasil Audiometri – tone &amp; speech audiometry 3</li> <li>- Otoscopy pneumatic (Siegle) 2</li> <li>- Memeriksa dan menginterpretasi hasil timpanometri 2</li> <li>- Pemeriksaan vestibular sederhana 4</li> <li>- Tes Ewing 2</li> <li>- Pemeriksaan Kuantitatif Penghidu 2</li> <li>- Nasofaringoskopi 2</li> <li>- Penilaian pengecap 4</li> <li>- Pemasangan tampon posterior 3</li> </ul> | THT/FJ                |
| 3. | Penyakit Hidung                             | <p>Etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deviasi septum hidung 2</li> <li>- Furunkel pada hidung 4A</li> <li>- Rhinitis akut 4A</li> <li>- Rhinitis vasomotor 4A</li> <li>- Rhinitis alergika 4A</li> <li>- Rhinitis kronik 3A</li> </ul>                                                             | THT/FJ                |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rhinitis medikamentosa 3A</li> <li>- Benda asing 4A</li> <li>- Epistaksis 4A</li> <li>- Pemasangan tampon posterior 3</li> <li>- Polip 2</li> <li>- Fraktur nasal 3A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 4. | Penyakit sinus hidung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinusitis akut 4A</li> <li>- Sinusitis frontal akut 2</li> <li>- Sinusitis maksilaris akut 3A</li> <li>- Sinusitis kronik 3A</li> <li>- Bilas sinus/ sinus lavage /punksi sinus 2</li> <li>- Etmoiditis akut 1</li> <li>- Tumor sinonasal 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | THT/FJ       |
| 5. | Penyakit Tenggorok             | <p>Etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faringitis akut 4A</li> <li>- Faringitis kronik 3A</li> <li>- Tonsilitis akut 4A</li> <li>- Tonsilitis kronik 3A</li> <li>- Laringitis akut 4A</li> <li>- Laringitis kronik 3A</li> <li>- Hipertrofi adenoid 2</li> <li>- Abses peritonsilar 3A</li> </ul> | THT/FJ       |
| 6. | Gangguan pada Kepala dan Leher | <p>Etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fistula dan kista brankial lateral dan medial 2</li> <li>- Higroma kistik 2</li> <li>- Tortikolis 3A</li> <li>- Abses Bezold 3A</li> </ul>                                                                                                                 | THT/FJ       |
| 7. | Radiologi sistem indra         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran pencitraan kondisi normal foto rontgen mata dan THT-KL</li> <li>- Gambaran pencitraan penyakit mata dan THT-KL: <ul style="list-style-type: none"> <li>o USG</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | Radiologi/YN |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rontgen</li> <li>○ CT scan</li> <li>- Pemeriksaan Radiologi sinus 2</li> <li>- Interpretasi radiologi sinus 3</li> </ul>                                                                             |             |
| 8. | Farmakologi penginderaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obat-obatan topikal untuk kelainan mata dan THT-KL meliputi:</li> <li>- Analgetik antiinflamasi</li> <li>- Steroid</li> <li>- anestesi local</li> <li>- Antimikroba</li> <li>- Antiseptik</li> </ul> | Farmako/SAN |

### Skenario Tema 3

#### “Telinga Anaku Sakit”

Seorang anak perempuan berusia 3 tahun atas nama anak Sofia dengan BB 15 kg dibawa oleh ibunya ke poliklinik THT dengan keluhan nyeri telinga kiri hebat sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai demam sejak 2 hari yang lalu. Seminggu sebelumnya, anak Sofia mengalami batuk, pilek, dan demam. Pasien cenderung berbicara dengan suara keras. Anak sudah diberikan obat antinyeri namun keluhan belum membaik. Riwayat mengorek telinga tidak ada. Riwayat keluar cairan sebelumnya tidak ada. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan:

KU : anak tampak kesakitan, rewel

TD : 110/80 mmHg

Tax : 38,0°C

Nadi : 105 x/menit

RR : 20x/menit

Status Lokalis:

Pemeriksaan otoskopi aurikula S tampak seperti gambar berikut:



| Telinga D                                                                                                                                                                                                                                                             | Telinga S                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preaurikula: tidak didapatkan fistel, nyeri tekan tragus (+)</li> <li>• Aurikula: normal, liang telinga lapang, membran timpani intact</li> <li>• Retroaurikula: tidak hiperemi, tidak edema, tidak ada sikatriks</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preaurikula: tidak didapatkan fistel, nyeri tekan tragus (+)</li> <li>• Aurikula: normal, liang telinga lapang, membran timpani yang menonjol, eritema, dan ada cairan di belakangnya</li> <li>• Retroaurikula: tidak hiperemi, tidak edema, tidak ada sikatriks</li> </ul> |
| Nasal D                                                                                                                                                                                                                                                               | Nasal S                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavum nasi: lebar</li> <li>• Konka inferior: edema (-), hipertrofi (-)</li> <li>• Mukosa: hiperemis (-), sekret (-)</li> <li>• Septum nasi: tidak deviasi</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavum nasi: lebar</li> <li>• Konka inferior: edema (-), hipertrofi (-)</li> <li>• Mukosa: hiperemis (-), sekret (-)</li> <li>• Septum nasi: tidak deviasi</li> </ul>                                                                                                        |
| Tenggorokan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tonsil: T2/T2, hiperemi (-)</li> <li>• Faring: hiperemi (-), hipertrofi (-)</li> <li>• Pembesaran KGB (-)</li> </ul>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Tenggorokan

- Tonsil: T2/T2, hiperemi (-)
- Faring: hiperemi (-), hipertrofi (-)
- Pembesaran KGB (-)

Setelah melakukan pemeriksaan, dokter memberikan resep antibiotik, antinyeri, antipiretik. Jika tidak membaik dokter merencanakan untuk melakukan miringotomi. Dokter meminta ibu Sofia untuk bersabar atas sakit yang dikeluhkan Sofia, serta menjelaskan penyakit Sofia pada ibunya.

## TBL

Skenario : Tema 3

Dosen : VI dan FJ

**Tugas Terstruktur**

| KELOMPOK | TOPIK          |
|----------|----------------|
| 1        | Jurnal reading |
| 2        | Jurnal reading |



## TEMA 4: PENYAKIT TELINGA

Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis Tema 4

Tabel 7.4.1 Daftar Masalah, Penyakit dan Keterampilan Klinis Tema 4

| DAFTAR MASALAH                                                                                                                                                                                                                            | DAFTAR PENYAKIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DAFTAR KETERAMPILAN KLINIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuli (gangguan fungsi pendengaran)<br>Telinga nyeri/sakit<br>Keluar cairan dari telinga<br>Telinga gatal<br>Telinga berdenging<br>Telinga terasa penuh<br>Daun telinga merah<br>Benda asing di dalam liang telinga<br>Benjolan di telinga | Tuli konduktif 2<br>Tuli perseptif 2<br>Tuli kongenital 2<br>Inflamasi pada aurikular 3A<br>Herpes zoster pada telinga 3A<br>Fistula preaurikuler 3A<br>Otitis eksterna 4A<br>Otitis media akut 4A<br>Otitismedia serosa 3A<br>Otitis media kronik 3A<br>Kolesteatoma 2<br>Serumen prop 4A<br>Trauma aurikuler 3B<br>Trauma aurikuler kongenital 2<br>Trauma akustik akut 3A<br>Benda asing 3B<br>Mastoiditis 3A<br>Miringitis bullosa 3A<br>Perforasi membran timpani 3A<br>Timpanosklerosis 2<br>Otosklerosis 3A<br>Presbiakusis 3A<br>Trauma akustik akut 3A<br>Mabuk perjalanan 4A<br>Labirintitis 2 | Inspeksi aurikular dan melihat meatus auditorius externus dengan otoskop<br>Pemeriksaan membran timpani dengan otoskop<br>Menggunakan lampu kepala<br>Tes pendengaran, pemeriksaan garpu tala (Weber, Rinne, Schwabach)<br>Tes pendengaran, tes berbisik<br>Intepretasi hasil Audiometri – tone & speech audiometry<br>Pemeriksaan pendengaran pada anak-anak<br>Otoscopy pneumatic (Siegle)<br>Memeriksa dan menginterpretasi hasil timpanometri<br>Pemeriksaan vestibular sederhana<br>Tes Ewing<br>Palpasi zygoma<br>Palpasi maksila<br>Palpasi nasal<br>Palpasi mandibula<br>Manuver Politzer 2<br>Manuver Valsalva 4<br>Pembersihan meatus auditorius eksternus dengan usapan 4<br>Pengambilan serumen menggunakan kait atau kuret 4<br>Pengambilan benda asing di telinga 3B<br>Parasentesis 2 |

|  |  |                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Inseri grommet tube 1<br>Menyesuaikan alat bantu dengar 2<br>Pemasangan tampon telinga 4 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kuliah Tema 4

Tabel 7.4.2 Daftar Kuliah Tema 4

| No | Topik                               | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bidang Ilmu/Dosen |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Penyakit Telinga Luar               | Etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari:<br>Inflamasi pada aurikular 3A<br>Herpes zoster pada telinga 3A<br>Fistula preaurikuler 3A<br>Otitis eksterna 4A<br>Kolesteatoma 1<br>Serumen prop 4A<br>Trauma aurikuler 3B<br>Kelainan aurikuler kongenital 2<br>Pemasangan tampon telinga 4 | THT/FJ            |
| 2  | Penyakit Telinga Tengah dan Mastoid | Etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari:<br>- Otitis media akut 4A<br>- Otitis media serosa 3A<br>- Otitis media kronik 3A<br>- Inseri grommet tube 1<br>- Mastoiditis 3A<br>- Miringitis bullosa 3A<br>- Perforasi membran timpani 3A<br>- Otosklerosis 3A<br>- Timpanosklerosis 2     | THT/FJ            |
| 3  | Penyakit Telinga Dalam              | Etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THT/FJ            |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | dan Gangguan Keseimbangan | <p>penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi, pencegahan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuli (kongenital, perseptif, konduktif) 2</li> <li>- Labirintitis 2</li> <li>- Presbiakusis 3A</li> <li>- Trauma akustik akut 3A</li> <li>- Menyesuaikan alat bantu dengar 2</li> </ul>                                                                                               |             |
| 4 | Keganasan THT-KL          | <p>Etiologi, faktor resiko, kriteria diagnosis meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, tatalaksana, komplikasi dari:</p> <p>Ca nasofaring (Karsinoma nasofaring 2)</p> <p>Ca hidung dan sinus paranasalis (Tumor sinonasal 2)</p> <p>Ca laring (Karsinoma laring 2)</p> <p>Ca telinga</p> <p>Tumor colli 2</p>                                                    | THT/FJ      |
| 5 | PA Keganasan sistem indra | <p>Gambaran PA keganasan pada mata dan THT-KL</p> <p>Keganasan intraorbita</p> <p>Keganasan ekstraorbita</p> <p>Ca nasofaring</p> <p>Ca hidung dan sinus paranasalis</p> <p>Ca laring</p> <p>Ca telinga</p>                                                                                                                                                                                                   | PA/ BIAN    |
| 6 | Hak-hak orang cacat       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk orang cacat</li> <li>- Identifikasi isu etik dalam konteks hak untuk orang cacat</li> <li>- Mengenali dan membedakan isu etik terkait hak untuk orang cacat dari isu yang lain</li> <li>- Empat dasar prinsip etik pada kasus tentang hak untuk orang cacat</li> <li>- Pertimbangan rasional untuk keputusan etik tentang hak untuk orang cacat</li> </ul> | Bioetik/DOB |

## Praktikum tema 4

| No | Topik           | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bidang Ilmu/Dosen |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | PA sistem indra | Mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran patologis pada sediaan preparat sistem indra : <ul style="list-style-type: none"><li>- Keganasan intraorbita</li><li>- Keganasan ekstraorbita</li><li>- Ca nasofaring</li><li>- Ca hidung dan sinus paranasalis</li><li>- Ca laring</li><li>- Ca telinga</li></ul> | PA/BIAN           |

## Skenario Tema 4

“Aku Pilek Berat”

Nn Aulia, perempuan berusia 25 tahun datang ke poliklinik THT RSKH dengan keluhan pilek yang tidak kunjung sembuh sejak 3 minggu yang lalu. Pilek tersebut disertai ingus kental berwarna kehijauan. Selain itu, pasien mengeluhkan hidungnya terasa tersumbat dan penciumannya berkurang. Pasien pernah merasakan ada lendir yang mengalir ke tenggorokan. Dalam satu minggu terakhir, pasien juga merasakan nyeri kepala dan nyeri di area pipi. Pasien juga mengeluhkan demam sejak satu minggu terakhir. Pasien tidak memiliki riwayat sakit gigi ataupun gigi berlubang. Riwayat alergi dan bersin-bersin disangkal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan:

KU : cukup

TD : 120/70 mmHg

Tax : 37,8°C

Nadi : 96 x/menit

RR : 17x/menit

Status Lokalis:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telinga D                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telinga S                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Preaurikula: fistel (-), nyeri tekan tragus (-)</li><li>• Aurikula: normal, liang telinga lapang, membran timpani intak</li><li>• Retroaurikula: hiperemi (-), edema (-), sikatriks (-)</li></ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Preaurikula: fistel (-), nyeri tekan tragus (-)</li><li>• Aurikula: normal, liang telinga lapang, membran timpani intak</li><li>• Retroaurikula: hiperemi (-), edema (-), sikatriks (-)</li></ul>                                             |
| Nasal D                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nasal S                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Regio maxillaris D: nyeri tekan (+), transluminasi (+)</li><li>• Cavum nasi: lebar</li><li>• Konka inferior: edema (+), hipertrofi (+)</li><li>• Mukosa: hiperemis (+), sekret (+) mukopurulen</li><li>• Septum nasi: tidak deviasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regio maxillaris S: nyeri tekan (+), transluminasi (+)</li><li>• Cavum nasi: lebar</li><li>• Konka inferior: edema (+), hipertrofi (+)</li><li>• Mukosa: hiperemis (+), sekret (+) mukopurulen</li><li>• Septum nasi: tidak deviasi</li></ul> |
| Tenggorokan                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tonsil: T2/T2, hiperemi (-)</li><li>• Faring: hiperemi (-), hipertrofi (-)</li><li>• Post nasal drip (+)</li><li>• Pembesaran KGB (-)</li></ul>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Setelah melakukan pemeriksaan transiluminasi, dokter memberikan resep antibiotik dan dekonjestan. Dokter menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan foto rontgen waters.

TBL

Skenario : Tema 4

Dosen : VI dan FJ

Tugas Terstruktur

| Kelompok | Topik          |
|----------|----------------|
| 3        | Jurnal reading |
| 4        | Jurnal reading |
| 5        | Jurnal reading |

## VIII. REFERENSI

- Artini W, Hutaeruk J, Yudisianil. Pemeriksaan dasar mata. Jakarta: Badan Penerbit FKUI; 2011
- Bailey's Head & Neck Surgery Otolaryngology. Byron J. Bayley MD FACS and Jonas T. Johnson MD. 2014.
- Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Kepala & Leher Edisi ketujuh Editor: Efiaty Soepardi, Nurbaiti Iskandar, Jenny Bashiruddin, Ratna Dwi Restuti, 2012.
- Boies Buku Ajar Penyakit THT Edisi 6 Editor: Adams Boies Highler, 2012.
- Bowling B. Kanski's Clinical ophthalmology: a systematic approach. London: Elsevier Health Sciences; 2016
- Brooks, G.F., Carrol, K.C., Butel, J.S., Morse, S. A., Mietzner, T.A., 2012. Mikrobiologi Kedokteran Jawetz, Melnick & Adelberg. EGC Edisi 25
- Cynthia Nau Cornelissen; Bruce D. Fisher; Richard A. Harvey. *Lippincott's Illustrated review: Microbiology* Third Edition. Lippincott William & Wilkins
- Current Diagnosis & Treatment Otolaryngology Head and Neck Surgery, Third Edition Ed. Anil K. Lalwani, 2012.
- Diseases of Ear, Nose & Throat, 6th Edition, PL Dhingra, 2013.
- Ehlers JP, Shah CP, editors. The Wills eye manual: office and emergency room diagnosis and treatment of eye disease, 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2012
- Geo F. Brooks; Karen C. Carroll; Janet S. Butel; Stephen A. Morse; Timothy A. Mietzner. *Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology* Twenty-Sixth Edition. A Lange Medical Book
- Goodman and Gilman. 2015. Dasar Farmakologi Terapi
- Harper RA. Basic ophthalmology. American Academy of Ophthalmology; 2010
- Katzung, et al. 2015. Farmakologi Dasar dan Klinik
- Kumar, Cotran, dan Robbins, 2013. Buku Ajar Patologi Edisi 9

- Loterio, R.K., Zamboni, D.S., Newton, H.J. 2021. Keeping the host alive – lessons from obligate intracellular bacterial pathogens. *Pathogen and Disease*, Vol. 79, Issue 9
- Louse. Britannica. <https://www.britannica.com/animal/louse>
- Lokida, D. et al., Underdiagnoses of *Rickettsia* in patients hospitalized with acute fever in Indonesia: observational study results. *BMC Infectious Diseases* volume 20, Article number: 364 (2020)
- Mayer Gene. Bacteriology Chapter twenty one: Rickettsia, Orientia, Ehrlichia, Anaplasma, Coxiella and Bartonella. <https://www.microbiologybook.org/mayer/rickettsia.htm>
- Michael Mohseni; Sharon Sung; Veronica Takov. Chlamydia. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537286/>
- Murray, Rosenthal, Pfaller. Medical Microbiology 7<sup>th</sup> Edition. Elsevier Saunders
- Olson, James. 2000. Clinical Pharmacology
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman,

- Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Riordan-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General ophthalmology, 18th ed., New York: Lange medical books/ McGraw-Hill Medical Pub.Division; 2011
- Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery 7 Ed. Edited by Michael J Gleeson, Ray C Clarke, 2008.
- Yueniwati, Y. 2018. Kenali Tumor Orbita melalui Pencitraan. UB Press
- Yueniwati, Y. 2023. Magnetic Resonance Spectroscopy pada Otak: Prinsip & Aplikasi Klinis. UB Press
- Yueniwati, Y. Ilmu Radiologi Klinis: Prinsip-Prinsip Pencitraan Diagnosis, Chapter Head & Neck. EGC: Yogyakarta



